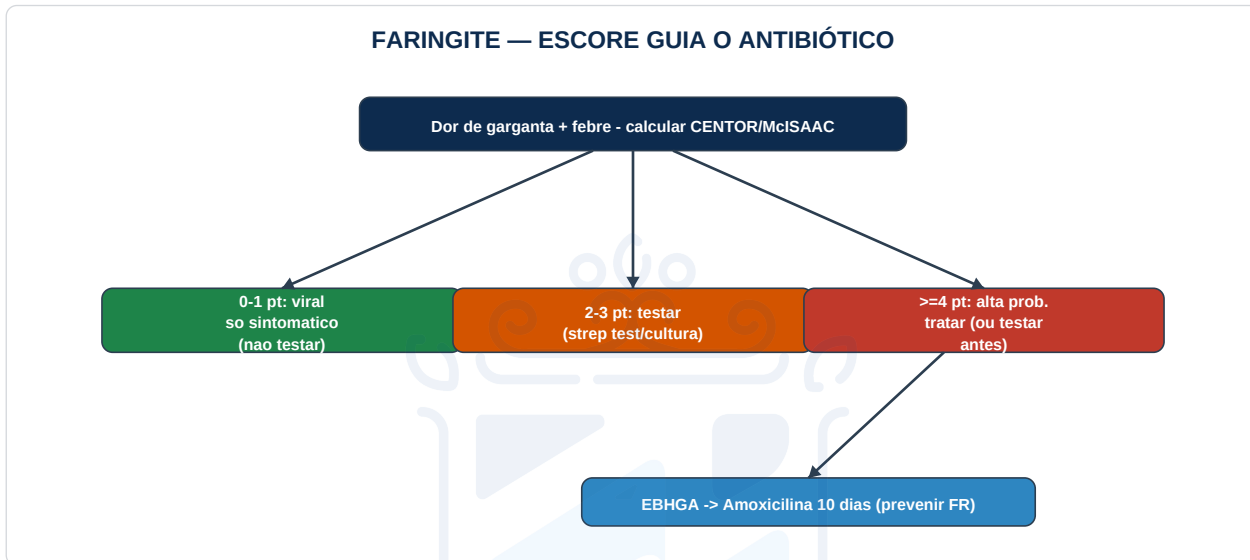


FARINGOAMIGDALITE AGUDA — VIRAL x EBHGA

FLUXOGRAMA — CENTOR/McISAAC



DEFINIÇÃO E ETIOLOGIA

O QUE É

- Inflamação da faringe e/ou amígdalas palatinas: dor de garganta, febre, odinofagia, mal-estar
- VIRAL (70-80%): mais comum, sobretudo < 3 anos (rinovírus, adenovírus, influenza, EBV) — autolimitada
- BACTERIANA (15-30%): EBHGA (*S. pyogenes*), pico 5-15 anos, rara < 3 anos
- Tratar EBHGA é mandatório para prevenir febre reumática (sequela imunomediada com dano cardíaco)

DIFERENCIAÇÃO CLÍNICA

Viral	Bacteriana (EBHGA)
Tosse, coriza, rinite	Início súbito de dor intensa
Conjuntivite, rouquidão	Febre alta (> 38,5 C)
Diarreia, exantema viral	Ausência de tosse/coriza
Úlceras/vesículas na orofaringe	Exsudato purulento + petéquias palatinas
Início gradual, febre baixa	Adenomegalia cervical anterior dolorosa; exantema escarlatiniforme

ESCORE DE CENTOR/McISAAC (> 3 anos)

Critério (+1 cada)	Pontuação total	Conduta
Febre > 38 C	0 - 1	Baixa (<10%): não testar/tratar
Ausência de tosse	2 - 3	Intermediária: testar (rápido/cultura)
Linfonodo cervical ant. doloroso	>= 4	Alta (>50%): tratar ou testar antes
Edema/exsudato amigdaliano	Idade 3-14: +1	15-44: 0 >=45: -1

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL**QUANDO E QUAL**

- Teste rápido (TRDA): escolha na urgência (minutos); especificidade > 95% (positivo confirma)
- Sensibilidade limitada (85-95%): TRDA negativo com alta suspeita (criança/adolescente) -> cultura
- Cultura de orofaringe: padrão-ouro (24-48h); indicada se TRDA negativo + alta suspeita
- Hemograma: não de rotina; só se toxemia, suspeita de abscesso ou diferencial (mononucleose)

TRATAMENTO — EBHGA (1a linha)**Rx ANTIBIÓTICO (PREVENIR FEBRE REUMÁTICA)**

Amoxicilina 50 mg/kg/dia VO (1-2 tomadas), por 10 dias (máx 1 g/dia) — preferida
OU Penicilina G Benzatina IM dose única: < 27kg = 600.000 UI | >= 27kg = 1.200.000 UI
Alergia NÃO anafilática: Cefalexina 50 mg/kg/dia VO 6/6h por 10 dias
Alergia anafilática: Claritromicina (superior à azitro na erradicação) OU Azitromicina 12 mg/kg/dia 5 dias OU Clindamicina
Viral: APENAS sintomático (analgésico/antitérmico, hidratação, dieta fria) — ATB é ineficaz/contraindicado
Retorno à escola após 24h de antibiótico (se bacteriana)

COMPLICAÇÕES DA EBHGA**POR QUE TRATAR CORRETAMENTE**

- Supurativas (por contiguidade): abscesso peritonsilar, otite média, sinusite, linfadenite cervical
- Não supurativas (imunomediadas): Febre Reumática Aguda (PREVENÍVEL com ATB correto) — cardite/valvopatia
- Glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica (GNDA) — NÃO é prevenida pelo tratamento
- RED FLAGS: trismo, abaulamento peritonsilar, desvio de úvula, sialorreia, estridor, dispneia
- Tonsilectomia: >= 7 episódios/ano, ou > 5/ano por 2 anos, ou > 3/ano por 3 anos

CHECKLIST DE ALTA

ANTES DE LIBERAR

- ☐ Dor de garganta controlada/tolerável; tolera líquidos (sem disfagia absoluta)
- ☐ Sem sinais de complicação (abscesso, celulite) nem dificuldade respiratória/estridor
- ☐ Receita explicada; reforçar completar 10 dias de ATB (ou dose única IM) na EBHGA
- ☐ Orientações de retorno: febre > 3 dias, dificuldade para respirar, sialorreia, piora da dor, trismo
- ☐ Retorno escolar após 24h de ATB (se bacteriana)

MODELO DE TRANSFERÊNCIA (complicação)

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Faringoamigdalite há ____, febre ____ C; Centor ____ pontos; oroscopia: ____ (exsudato/abaulamento/desvio de úvula).
- Complicação: abscesso peritonsilar / epiglote / celulite cervical / desidratação.
- Via aérea: pérvia/ameaçada; sialorreia/estridor: sim/não.
- Conduta: hidratação, analgesia, ATB _____. Solicito avaliação ORL urgente / drenagem / ATB EV.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Criança de 8 anos com início súbito de dor de garganta, febre 39, exsudato amigdaliano, adenomegalia cervical dolorosa e SEM tosse. Centor alto. Conduta?

- A) Apenas sintomático, pois toda faringite é viral
- B) Amoxicilina por 10 dias (ou penicilina benzatina IM) para tratar EBHGA e prevenir febre reumática
- C) Azitromicina por 3 dias como primeira linha
- D) Corticoide isolado
- E) Antiviral oral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o principal objetivo do tratamento antibiótico da faringite estreptocócica?

- A) Encurtar o resfriado
- B) Prevenir a febre reumática aguda (e complicações supurativas)
- C) Prevenir a glomerulonefrite pós-estreptocócica
- D) Tratar a tosse
- E) Reduzir a coriza

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Paciente com escore de Centor/McIsaac de 0-1 ponto. Qual a conduta recomendada?

- A) Antibiótico empírico imediato
- B) Não testar nem tratar com antibiótico; manejo sintomático
- C) Penicilina benzatina IM
- D) Cultura obrigatória
- E) Internação

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o teste rápido para EBHGA, é correto:

- A) Tem baixa especificidade
- B) Tem alta especificidade (>95%); se negativo com alta suspeita clínica, confirmar com cultura
- C) Substitui a clínica em todos os casos
- D) É positivo em faringites virais
- E) Não tem valor diagnóstico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual achado sugere etiologia VIRAL da faringite?

- A) Exsudato purulento e petéquias palatinas
- B) Tosse, coriza, conjuntivite e início gradual
- C) Adenomegalia cervical anterior dolorosa
- D) Exantema escarlatiniforme
- E) Ausência de tosse com febre alta

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Quadro de alta probabilidade de EBHGA (Centor alto): trata-se com amoxicilina 10 dias (ou penicilina benzatina IM), cujo objetivo principal é prevenir a febre reumática. Macrolídeo fica para alérgicos anafiláticos.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O objetivo primário do ATB na faringite estreptocócica é prevenir a febre reumática aguda (e complicações supurativas). A GNDA pós-estreptocócica NÃO é prevenida pelo tratamento da faringite.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Centor/McIsaac 0-1 indica baixa probabilidade de EBHGA (<10%): não se testa nem se trata com antibiótico; o manejo é sintomático. Testar fica para 2-3 pontos; tratar/testar para ≥ 4 .

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O teste rápido tem alta especificidade (>95%) — positivo confirma. Como a sensibilidade é menor, um resultado negativo com alta suspeita clínica (criança/adolescente) deve ser confirmado por cultura.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Tosse, coriza, conjuntivite, rouquidão e início gradual apontam etiologia viral. Exsudato, petéquias palatinas, adenomegalia dolorosa, exantema escarlatiniforme e ausência de tosse sugerem EBHGA.

SM24
Suporte ao Plantão Médico